

TEMA 1.13 • PEDIATRÍA

Púrpura y Anemia en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.035
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Púrpura y Anemia en Pediatría

1. Púrpura en Pediatría

- **Definición:** Lesiones cutáneas que **no blanquean con la compresión**.
- Púrpura puntiforme: **petequias**
- Púrpura por manchas: **equimosis**
- Púrpura palpable (solevantada): leucocitoclástica/vasculítica

Enfrentamiento inicial: Hemograma con recuento de plaquetas.

TABLA 1.13.1: TIPO VS PLAQUETAS		
TIPO	PLAQUETAS	CAUSAS PRINCIPALES
Trombocitopénico	Bajas	PTI, SHU, CID, fármacos
No trombocitopénico	Normales	Púrpura de Schönlein-Henoch, enfermedad de Von Willebrand, fármacos

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar **meningococcemia** (instalación aguda, grave) o **leucemia aguda** (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas).

Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH)

Causa: Enfermedad postinfecciosa (depósitos de IgA en vasos). Lo más frecuente: postamigdalitis estreptocócica.

- **Tetrada clínica:**
- **Púrpura palpable** en extremidades inferiores y zona glútea (vasculítica, leucocitoclástica)
- **Glomerulonefritis aguda** ← lo más importante, determina el pronóstico
- **Dolor abdominal** difuso + hemorragia digestiva baja (hematoquezia)
- **Artritis / artralgias**

Diagnóstico: Clínico. Si duda → biopsia de piel (depósitos de IgA).

Estudio: Función renal (el más importante, determina pronóstico) + hemograma (plaquetas normales).

- **Tratamiento:**
- En general: **observación** (autolimitada)
- Corticoides orales en altas dosis si: dolor abdominal intenso, glomerulonefritis, más que solo manifestaciones cutáneas
- La evidencia no es concluyente, pero se recomiendan en esos casos en la práctica clínica

Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)

Causa: Autoinmune, muchas veces **postinfecciosa** (2–4 semanas después de un resfriado o infección respiratoria alta).

- **Clínica (hemostasia primaria):**
- **Petequias** (orientan a alteración plaquetaria)
- Equimosis
- Sangrado mucoso: **epistaxis** (frecuente) + gingivorragia
- Puede haber hemorragia digestiva, hematuria

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

PTI NO debe tener: fiebre, esplenomegalia, adenopatías, ni anemia. Si aparecen → sospechar **leucemia aguda** → biopsia de médula ósea.

Diagnóstico: Hemograma: **trombocitopenia aislada** (GR y GB normales). Si duda → biopsia MO (megacariocitos aumentados, resto normal).

Tratamiento según plaquetas:

TABLA 1.13.2: PLAQUETAS VS CLÍNICA

PLAQUETAS	CLÍNICA	TRATAMIENTO
> 20.000/mm ³	Bien	Observación + reposo relativo
< 20.000/mm ³	Estable	Prednisona oral
Cualquier cifra	Hemorragia grave (ej. TEC, hemorragia intracraneal)	Inmunoglobulina G EV en altas dosis (tratamiento de rescate)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El tratamiento de rescate del PTI con hemorragia grave es la **IgG EV**, **NO** las plaquetas. La transfusión de plaquetas se reserva como última línea.

2. Anemia en Pediatría

Definición: Hemoglobina < **percentil 10** para la edad (no hay un valor fijo único).

Valores clave por edad:

TABLA 1.13.3: EDAD VS HB < (= ANEMIA)

EDAD	HB < (= ANEMIA)
Recién nacido	< 15 g/dL
3 meses	< 9 g/dL
12 meses (y adultos)	< 12 g/dL

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Aprende solo estos 3 valores: **15 – 9 – 12** (RN, 3 meses, 1 año). Los intermedios se interpolan.

Anemia Fisiológica del Lactante

- Ocurre entre los **2–6 meses** (nadir a los 3 meses) - Hemoglobina nunca < 9 g/dL (si está ≥ 9 → no es anemia, es fisiológico) - No requiere tratamiento

Anemia Ferropénica en Pediatría

- Aparece habitualmente después de los **6 meses** (especialmente con lactancia materna exclusiva sin suplemento) - La leche materna es ideal, pero tiene **bajo contenido de hierro**

- **Profilaxis con suplemento de hierro:**
- Lactante sano: desde los **4 meses** hasta el año de vida
- RN prematuro: desde los **2 meses** o cuando **duplica su peso de nacimiento** (lo que ocurra primero)

Estudio: Hemograma + reticulocitos + **perfil de hierro** (igual que adulto).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 7 años con aparición brusca de púrpura palpable simétrica en piernas y glúteos, artritis de tobillos, dolor abdominal cólico y hematuria microscópica. 2 semanas antes tuvo faringitis. Plaquetas 280.000. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Púrpura y Anemia en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- PSH (Púrpura de Schönlein-Henoch): vasculitis IgA; púrpura palpable EEL + artritis + dolor abdominal + nefritis
- PSH: post-estreptocócica o viral, diagnóstico clínico, autolimitada; nefritis seguimiento 6 meses
- PTI: plaquetas <100k post-viral; >20k sin sangrado → observar; <20k o sangrado → prednisona 1 mg/kg
- PTI con hemorragia grave: IgG EV 1 g/kg + plaquetas; esplenectomía si PTI crónica refractaria
- Anemia por déficit de hierro: más frecuente; hierro elemental 3-6 mg/kg/día por 3 meses
- Valores normales Hb: RN >15 g/dL, 3 meses >9 g/dL (nadir fisiológico), 12 meses >12 g/dL

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÚRPURA Y ANEMIA EN PEDIATRÍA)**PREGUNTA 1**

Niño de 7 años con aparición brusca de púrpura palpable simétrica en piernas y glúteos, artritis de tobillos, dolor abdominal cólico y hematuria microscópica. 2 semanas antes tuvo faringitis. Plaquetas 280.000. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
- B)** Leucemia aguda
- C)** Púrpura de Schönlein-Henoch
- D)** Meningococcemia
- E)** Síndrome hemolítico urémico

PREGUNTA 2

Niño de 5 años con petequias y equimosis diseminadas de aparición súbita. Hace 2 semanas tuvo varicela. Plaquetas 12.000/mm³. Hemograma normal excepto plaquetopenia. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- A)** Observación sin tratamiento, resolución espontánea esperada
- B)** Transfusión de plaquetas profiláctica
- C)** Prednisona 1-2 mg/kg/día por 2-4 semanas
- D)** Esplenectomía de urgencia
- E)** Antibióticos EV por sospecha de sepsis

PREGUNTA 3

Lactante de 10 meses con lactancia materna exclusiva hasta los 8 meses, pálido, irritable, con anorexia. Hemoglobina 8.5 g/dL, VCM 65 fL, ferritina 4 ng/mL. ¿Cuál es el tratamiento?

- A)** Transfusión de glóbulos rojos
- B)** Hierro elemental oral 3-6 mg/kg/día por 3 meses
- C)** Ácido fólico 1 mg/día
- D)** Vitamina B12 IM
- E)** Cambiar a fórmula de soya

RESUMEN: PÚRPURA Y ANEMIA EN PEDIATRÍA

:::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). :::: Causa: Enfermedad postinfecciosa (depósitos de IgA en vasos). Lo más frecuente: postamigdalitis estreptocócica. Tetrad clínica: 1. Púrpura palpable en extremidades inferiores y zona glútea (vasculítica, leucocitoclástica) 2. Glomerulonefritis aguda ← lo más importante, determina el pronóstico 3. Dolor abdominal difuso + hemorragia digestiva baja (hematoquezia) 4. Artritis / artralgiás